

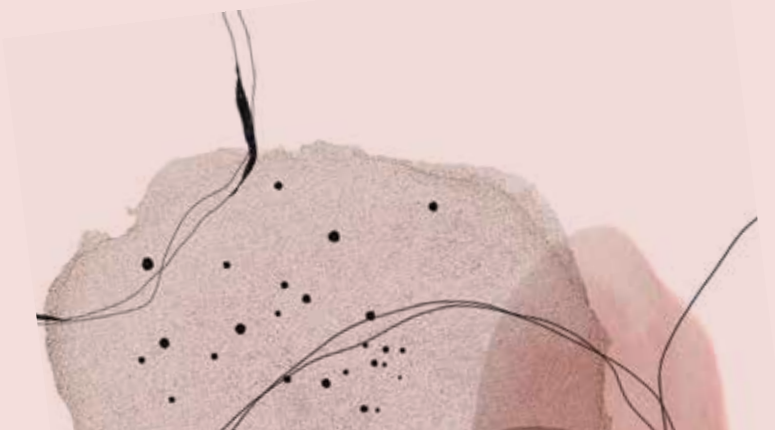
- b) Es importante preguntar si tiene alguna preocupación, si acaso la obesidad lo fuera, o no la menciona. Hábitos de alimentación, si come frutas, verduras, cuántas meriendas lleva a la escuela. ¿Cómo pasa su día, si juega, hace deportes, si emplea pantallas y cuánto tiempo?
- c) Es recomendable cuidar las expresiones, si bien es oportuno dar el diagnóstico, es trascendental generar alianza y confianza, para permitir continuar en su seguimiento.
Evitar las palabras "gordo", "gordito" y buscar estrategias posibles, mencionar su salud actual y futura, considerar si le parece puede realizar algún cambio.
- d) Por ejemplo, hemos detectado que has subido de peso, Crees/cree saber si ha habido algún cambio? Crees/cree que podrías hacer algo para mejorar tu/ salud? (si se siente cómodo hablar con el paciente, aunque se involucra a su familia).
¿Saben que la Actividad Física es saludable? Conociendo los beneficios del ejercicio, pensar en cuál actividad podría incorporar.
Si come pocas frutas y/o verduras, ¿crees/cree que puedas probar o incorporar alguna diariamente? ¿O bien aumentar el número que consumes?

AMPARO, 10 AÑOS

- a) Bajo Peso para la edad gestacional y más si ganó rápidamente peso, comienzo de obesidad antes de los 5 años, otros familiares con obesidad.
- b) Obesidad severa con talla normal.
- c) Glucemia, hepatograma, perfil lipídico. Debe descartar enfermedad hepática no alcohólica, descartar síndrome metabólico.
- d) Obesidad central, HDL < 40mg% y Triglicéridos > 110 mg%- 3 de 5 criterios, es diagnóstico de Síndrome Metabólico.
- e) No desayuna, consume ultraprocesados (jugo, alfajor, galletas), poco consumo de agua, aparentemente pocas frutas y verduras.
- f) Posibles estrategias: siempre focalizando en la salud. ¿Cómo ves tu peso? ¿Podrías mejorar algunas de tus costumbres? ¿Qué recordás haber hablado con la nutricionista? ¿Creés poder cambiar algo? Elijamos algunos aspectos, ejemplo: ¿podrías tomar más agua? ¿Recordás cuanto debes tomar en el día?

Actividad: lo ideal sería que todos los días hicieras actividad física, al menos 60 minutos. ¿Podríamos cambiar celular por algo de movimiento? ¿Qué podría ser? Dando posibilidad de que Amparo elija y si no, dar opciones, ¿Y si buscaras música en el celular e hicieras coreografías? ¿andar en bicicleta o jugar a la pelota?

Es muy importante el seguimiento de Amparo, volver a verla, para ver sus logros, armar nuevas estrategias.



4

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

// DRA. KARINA ANDREA GUTSON*

Médica Pediatra. Especialista en Desarrollo Infantil UBA.
Miembro del Comité de Crecimiento y Desarrollo SAP.
Formación en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez.
Actualmente Pediatra del Desarrollo en el Centro de Rehabilitación de FLENI
- Sede Escobar.

* Conflicto de intereses: ninguno que declarar



SEBASTIÁN, 18 MESES

Sus padres consultan al pediatra porque el niño aún no habla.

Antecedentes embarazo controlado y normal. Parto institucional cefálico – Apgar 8/9 RNT-PAEG presento ictericia, requirió LMT por 3 días. Alimentación lactancia materna por 6 meses, semisólidos comenzó con dificultades, problemas para aceptar variedad y texturas. Vacunas completas.

Antecedentes de enfermedades presento 2 OMA, cuadros de CVAS algunos con fiebre. Dos episodios de diarrea.

Concurre a jardín maternal. Padre empleado en supermercado, sano. Primario completo, secundario concurrió un año. Madre empleada en casas de familias, 3 veces por semana. Primario completo. Cuando la madre trabaja se queda al cuidado de una vecina.

Entre los **antecedentes familiares** surge que Mateo tiene un primo hermano con diagnóstico de TEA. El pediatra observa el desarrollo utilizando el IODI y encuentra pautas de alarma (zona roja del IODI): no responde a su nombre ni a indicaciones sencillas como dar la mano, no imita gestos como aplaudir o saludar y corrobora que durante la consulta el niño no dice ninguna palabra y que emite una jerga no comunicativa.

Realiza un **examen físico y nutricional**, lo encuentra eutrófico, sin dismorfias, visceromegalias ni estigmas neurocutáneos, examen neurológico motor normal. Perímetro cefálico en percentil 50. Nota que Sebastián no sostiene el contacto visual durante la interacción, no señala objetos para compartir interés y que su juego es de tipo sensoriomotor, no simbólico.

¿Cuál es el paso siguiente luego de realizar una historia clínica orientada al desarrollo?

- Aplicar una evaluación estandarizada de pesquisa: por ejemplo, M-CHAT/RF y solicita potenciales evocados auditivos.
- Establecer diagnóstico clínico de autismo y derivar a consulta con genética para realizar el diagnóstico etiológico.
- Derivar al neurólogo y esperar a que se complete la evaluación etiológica para luego establecer el tratamiento.
- Contraindica las vacunas de los 18 meses.

**Después de finalizar la lectura del capítulo,
compare sus respuestas con las que figuran en Clave de Respuestas.**



OBJETIVOS

- ◆ Identificar las características clínicas principales del TEA en distintas etapas del desarrollo infantil.
- ◆ Reconocer las señales de alerta y factores de riesgo asociados al TEA desde la primera infancia.
- ◆ Comprender la diferencia entre diagnóstico categórico, etiológico y funcional en el abordaje del TEA.
- ◆ Describir las comorbilidades médicas y psiquiátricas más frecuentes en personas con TEA.
- ◆ Aplicar criterios clínicos y herramientas para la vigilancia, como el IODI y para la pesquisa específica como el M-CHAT-R/F, en la detección temprana.
- ◆ Interpretar el rol del pediatra en la evaluación integral y en la coordinación de interconsultas con especialistas.
- ◆ Reconocer la importancia de diseñar intervenciones personalizadas según el perfil funcional del paciente y centrado en proporcionar estrategias a las familias.
- ◆ Identificar estrategias para mejorar la experiencia de consulta médica en niños con TEA.
- ◆ Promover la inclusión educativa y social de niños con TEA, en el marco de los derechos establecidos por la Convención sobre Discapacidad.
- ◆ Proponer acciones concretas para acompañar a las familias en el proceso diagnóstico y terapéutico.
- ◆ Valorar el impacto emocional del diagnóstico en los cuidadores y la importancia del acompañamiento profesional.



ESQUEMA DE CONTENIDOS

Trastornos del espectro autista



GLOSARIO

IODI: Instrumento para la Observación del Desarrollo Infantil.

ASQ-3: Ages and stages Questionnaire - 3.

M-CHAT: Modified Checklist for Autism in Toddlers. Lista de chequeo modificada para autismo en niños pequeños.

PRUNAPE: Prueba Nacional de Pesquisa.

CSBS DP: Communication and Symbolic Behavior Scales. Developmental Profile. Infant Toddler Checklist. Cuestionario del bebé y niño pequeño.

M-CHAT-R/F: Modified Checklist for Autism in Toddlers. Revised with Follow-Up. Lista de chequeo modificada para autismo en deambuladores. Revisada con seguimiento.

ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule. Escala de Observación Diagnóstica del Autismo.

ADI-R: Autism Diagnostic Interview- Revised. Entrevista de Autismo Revisada.

Escala CARS: Childhood autism rating scale. Escala de autismo infantil.

AMSE: Autism Mental Status Exam. Examen del Estado Mental en Autismo.

WISC: Wechsler Intelligence Scale for Children. Escala de inteligencia para niños.

WPPSI: Wechsler Preschool & Primary Scale of Intelligence. Escala de inteligencia para niños preescolares y escolares.

DAS: Differential Ability Scales. Escalas de Habilidad Diferencial.

TEACCH: Treatment and Education of Autistic and Related Communication-Handicapped Children. Tratamiento y educación de niños con autismo y problemas asociados de comunicación.

RDI: Relationship Development Intervention. Intervención para el desarrollo de las relaciones.

SCERTS: Comunicación Social (CS), Regulación Emocional (RE) y Apoyo Transaccional (AT).



INTRODUCCIÓN

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo de condiciones del neurodesarrollo que afectan la comunicación, la interacción social y el comportamiento, lo cual tiene un impacto significativo en la calidad de vida de las personas con TEA y sus familias.

Su prevalencia ha aumentado en las últimas décadas, lo que hace que sea esencial que los pediatras estén bien informados acerca de su identificación, diagnóstico y manejo.

Debido al conocido fenómeno de la mayor neuroplasticidad en el período de desarrollo, la detección y diagnóstico tempranos son cruciales para el tratamiento efectivo.

La concientización y la comprensión sobre los TEA pueden ayudar a reducir la estigmatización y promover la inclusión social. Es común la presencia de **comorbilidades** en las personas con TEA. Estas incluyen:

- Otros trastornos del desarrollo.
- Alteraciones del estado de ánimo.
- Trastorno de ansiedad.
- Entidades clínicas: epilepsia, trastornos del sueño, alteraciones gastrointestinales y déficits nutricionales, entre otras.

La atención de estos niños es un desafío y requiere algunas consideraciones que facilitarán la tarea. Este capítulo ofrece una **Guía para el pediatra sobre el TEA**, incluyendo aspectos clínicos, diagnóstico, necesidad de intervenciones, y apoyo a las familias.

Marco conceptual

El término **autismo** fue acuñado por primera vez por el psiquiatra Eugen Bleuler en 1911. Sin embargo, no fue hasta la década de 1940 que el autismo comenzó a ser estudiado y descrito en la literatura médica. En la década de 1980, se produjo un cambio significativo en la comprensión del autismo a partir de la conceptualización del espectro autista de Lorna Wing, donde se incluyeron los casos más leves. Por lo tanto, si bien antes el autismo era concebido dentro de las enfermedades raras, con el cambio de paradigma se ha incrementado significativamente su diagnóstico. Desde entonces, tanto la prevalencia como la investigación sobre los TEA han avanzado exponencialmente, y se han desarrollado nuevos tratamientos y estrategias de intervención.

La **prevalencia** de los TEA varía según la fuente y el criterio de diagnóstico utilizado. La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que **1 de cada 127 niños** en todo el mundo tiene TEA¹. Mientras tanto, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) señala una prevalencia de **1 de cada 31 niños en Estados Unidos en el año 2022**, una verdadera epidemia².

¹ Zeidan J, Fombonne E, Scorsah J, Ibrahim A, Durkin MS, Saxena S, Yusuf A, Shih A, Elsabbagh M. Global prevalence of autism: A systematic review update. *Autism Res.* 2022 May;15(5):778-790. doi: 10.1002/aur.2696. Epub 2022 Mar 3. PMID: 35238171; PMCID: PMC9310578.

² Shaw KA, Williams S, Patrick ME, et al. Prevalence and Early Identification of Autism Spectrum Disorder Among Children Aged 4 and 8 Years — Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 16 Sites, United States, 2022. *MMWR Surveill Summ* 2025;74(No. SS-2):1–22. DOI: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.ss7402a1>

En **Argentina** no hay estudios poblacionales que permitan conocer la prevalencia de TEA. Si bien el diagnóstico es más frecuente en varones con una relación de 1 cada 4 mujeres, cada vez se diagnostica más el autismo en la población femenina³. Existen diferencias de género en la presentación clínica. Se describe el fenómeno de **“camuflaje”** en las mujeres, en las que las dificultades sociales y de comunicación son solapadas por habilidades adaptativas aprendidas, que concitan una mayor incidencia de comorbilidades como trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. El autismo suele ser más reconocido en la población femenina cuando se asocia a discapacidad intelectual.

ROL DEL PEDIATRA

El rol del pediatra en la atención de niños con trastorno del espectro autista incluye diferentes habilidades profesionales.

1. **Detección temprana:** es crucial para el diagnóstico y tratamiento efectivo de los niños con TEA. Los pediatras debemos estar atentos a los signos de alerta en la infancia temprana. Para ello, la vigilancia del desarrollo y el uso de herramientas de pesquisa para trastornos inaparentes del desarrollo es muy importante.
2. **Conocimiento de la variedad de expresiones clínicas:** los TEA constituyen un espectro, lo que significa que cada niño puede presentar síntomas y características únicas, que varían en el tiempo. Es importante estar familiarizados con la variedad de síntomas y características a lo largo del tiempo. Asimismo, tener en cuenta que es común la asociación de TEA con otros trastornos del desarrollo y comorbilidades psiquiátricas entre otras.
3. **Atención a las comorbilidades** y precaución sobre las manifestaciones atípicas de los síntomas de enfermedades comunes.
4. **Evaluación integral** que incluya la observación del comportamiento, la historia clínica y las pruebas diagnósticas es esencial para la detección temprana y el adecuado diagnóstico de los TEA.
5. **Trabajo coordinado:** se debe contar con una red de profesionales para efectuar las interconsultas, y tener criterio para derivar a especialistas y trabajar en colaboración, para brindar una atención integral a estos niños.
6. **Tratamiento y terapias:** conocer las opciones de tratamientos disponibles para los pacientes con TEA, como la terapia conductual, la terapia ocupacional y la terapia de habla, entre otros.
7. **Atención de los pacientes** teniendo en cuenta algunas particularidades que fortalecerán la relación médico-paciente-familia, brindando una atención respetuosa y personalizada.

³ Ochoa-Lubinoff C, Makol BA, Dillon EF. Autism in Women. *Neurol Clin.* 2023 May;41(2):381-397. doi: 10.1016/j.ncl.2022.10.006. Epub 2023 Feb 19. PMID: 37030965.

8. **Importancia de la inclusión:** promover la inclusión de los niños con TEA en la sociedad y en la comunidad, y brindar apoyo para que puedan participar plenamente en la vida social y educativa.
9. **Apoyo familiar:** el diagnóstico de TEA suele tener un impacto significativo en las familias. Es importante que los pediatras les ofrezcamos apoyo y recursos para ayudarlas a transitar el diagnóstico y el tratamiento. Debemos contar con recursos y referencias para las familias y los niños como organizaciones de apoyo, grupos de terapia y servicios de intervención temprana. Asimismo, existe mayor riesgo de TEA y otros trastornos del desarrollo en hermanos de personas diagnosticadas.

1. Detección temprana

La detección temprana es posible si se realiza vigilancia del desarrollo durante los controles en salud. La vigilancia es un proceso flexible que requiere dedicar tiempo de la consulta a los temas del desarrollo infantil. Para ello **se recomienda:**

- Escuchar y atender a las preocupaciones que plantea la familia o la institución escolar. En general, los padres y docentes de educación inicial son los primeros que notan comportamientos poco comunes en los niños, como la dificultad para alcanzar adecuadamente los hitos del desarrollo.
- Tener presente las señales de alerta en el desarrollo. Tabla 1 y factores de riesgo Tabla 2. Para ello es conveniente emplear una guía sistemática para observar el desarrollo infantil.

Por ejemplo, en **Argentina, se creó el Instrumento de observación del desarrollo infantil (IODI) o se puede usar el ASQ-3**, entre otros. Estas son listas de chequeo para facilitar la tarea del pediatra a la hora de evaluar los hitos de desarrollo esperables según la edad de los niños. El consenso argentino sobre trastornos del espectro autista brinda información completa y detallada sobre estos aspectos.

- Utilizar herramientas de pesquisa de desarrollo. Esto permite detectar niños aparentemente sanos, en riesgo de presentar un trastorno del desarrollo. La **PRUNAPE es un método creado en Argentina** para detectar niños menores de 6 años con riesgo en el desarrollo.
- También existen instrumentos para detectar específicamente riesgo de TEA. Si bien en nuestro país no se recomienda su empleo sistemático en todos los niños, instrumentos como el **M-CHAT R/F** - Lista de chequeo modificada y revisada para autismo en niños pequeños, podrían utilizarse en caso de sospecha de TEA. Tabla 3
- Aprovechar la consulta espontánea para observar el comportamiento y los hitos del desarrollo. Muchas veces, la familia sólo consulta al pediatra cuando los niños se enferman. Especialmente aquellos con problemas del desarrollo, que suelen tener más dificultades de comportamiento en el contexto de una visita médica.

Tabla 1. Señales de alerta en TEA

Alteraciones en la interacción social recíproca	Contacto visual inusual, poco sostenido para regular la interacción social. Escasa expresividad del rostro. Escaso interés en compartir, en una interacción social. Falta de respuesta al nombre luego de los 10 meses.
Alteraciones en la comunicación	Ausencia de señalamiento para mostrar. Falta de coordinación de la mirada en la comunicación no verbal. Prosodia inusual.
Comportamientos repetitivos e intereses restringidos	Movimientos repetitivos con objetos. Movimientos atípicos con el cuerpo, de los brazos, las manos o los dedos.

Existen múltiples factores y condiciones que se asocian con mayor prevalencia de TEA.

Tabla 2. Factores de Riesgo

- Hermano con trastorno del espectro autista.
- Defectos de nacimiento asociados con malformaciones del SNC y/o disfunción, incluyendo parálisis cerebral.
- Edad gestacional al nacimiento menor a 35 semanas.
- Padres con historia de esquizofrenia/psicosis /trastornos del estado de ánimo o algún otro trastorno mental o del comportamiento.
- Uso de valproato durante el embarazo.
- Discapacidad Intelectual.
- Encefalopatía neonatal o epiléptica, incluyendo espasmos infantiles.
- Malformaciones congénitas múltiples.
- Anomalías cromosómicas, tales como el Síndrome de Down.
- Trastornos genéticos, tales como el Síndrome de fragilidad del X.
- Distrofia muscular, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis.

Tabla 3. Instrumentos de pesquisa de TEA. Para niños/as entre:

6 a 24 meses	CSBS DP: Communication and Symbolic Behavior Scales. Developmental Profile. Infant Toddler Checklist. Cuestionario del bebé y niño pequeño.
16 a 30 meses	M-CHAT-R/F: Modified Checklist for Autism in Toddlers. Revised with Follow-Up. Lista de chequeo modificada para autismo en niños pequeños. Revisada con seguimiento.

Fuente: www.panacea.org

2. Conocimiento sobre la variedad de expresiones clínicas

Decimos que los **TEA constituyen un espectro**, ya que, partiendo de los criterios de diagnóstico, las manifestaciones entre personas con la misma condición son muy heterogéneas, Tabla 4. Asimismo, la expresión de los síntomas varía según el momento de la vida de un mismo sujeto.

Presentación durante:

Los **dos primeros años de vida**:

- Retrasos en el habla/lenguaje.
- Falta de contacto visual y un interés limitado en socializar.
- Estancamiento o regresión de las habilidades sociales después de un desarrollo temprano típico. Aproximadamente entre un cuarto y un tercio de los niños con TEA alcanzan los hitos tempranos del lenguaje, pero tienen una regresión o estancamiento de las habilidades del lenguaje, la comunicación y/o sociales, entre los 15 y los 24 meses de edad. La regresión de las habilidades puede ser gradual o repentina y puede ocurrir en el contexto de retrasos del desarrollo preexistentes o un desarrollo atípico.

En niños **en edad preescolar**:

- Falta de interés en la socialización.
- Ausencia o retraso en el desarrollo de las habilidades del habla y del lenguaje.
- Marcada resistencia al cambio.
- Intereses restringidos.

En niños con un fenotipo menos severo, los síntomas pueden evidenciarse inicialmente en el **jardín de infantes o más tarde**.

- Pueden presentar alteraciones de la conducta (por ejemplo: conductas disruptivas, dificultad para seguir instrucciones debido a un enfoque excesivo en los intereses preferidos).
- O síntomas de una afección coexistente: como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ansiedad, marcada selectividad alimentaria. El desarrollo social y del lenguaje atípico puede hacerse evidente sólo tras una revisión más cuidadosa del desarrollo general del niño.

En la población de **niñas y mujeres**, los síntomas pueden ser menos evidentes, lo que dificulta el diagnóstico. Los signos característicos incluye:

- Dificultades sociales.
- Estilos de comunicación únicos.
- Intereses internos, pero socialmente aceptables.
- Alta sensibilidad a los estímulos sensoriales.

Tabla 4. Características principales de los Trastornos del Espectro Autista

Aspecto del desarrollo	Característica
Comunicación verbal	Los/as niños/as con TEA pueden tener habilidades lingüísticas adecuadas, pero encuentran dificultades para utilizarlas en una comunicación recíproca o en determinados contextos sociales. Algunos/as niños/as no emplean lenguaje verbal y requieren el apoyo de los Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación (SAAC) que sustituyen y apoyan al lenguaje oral, respectivamente e incluyen diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos (fotografías, dibujos, pictogramas, palabras o letras) como gestuales (mímica, gestos o signos manuales).
Comunicación no verbal	Los/as niños/as con TEA pueden presentar dificultades para comprender el significado de gestos o expresiones faciales de otras personas, así como también de otros elementos de relevancia para la interacción, tales como la postura corporal o el contacto visual.
Interacción social	Algunos/as niños/as con TEA pueden tener dificultades para relacionarse con otras personas, comprender el entorno y desenvolverse en determinadas situaciones sociales. A veces pueden realizar acercamientos sociales inusuales o inadecuados en las interacciones con otras personas o presentar problemas para adaptar su comportamiento a distintos contextos o situaciones sociales. Es posible que presenten también problemas para comprender las reglas sociales “no escritas” o que les sea difícil entender o expresar las emociones de forma adecuada al contexto.
Flexibilidad de comportamiento y de pensamiento	Algunos/as niños/as con TEA pueden tener dificultades para responder de manera flexible a las demandas de los diferentes contextos y ajustar su forma de pensar y de comportarse. Por esta razón, adaptarse a los cambios o a situaciones imprevistas puede significarles un gran esfuerzo y generarles malestar, angustia o ansiedad. Esto se traduce en presentar insistencia para que las cosas sucedan siempre de la misma manera, en la disposición de un repertorio limitado de intereses específicos o en patrones de comportamiento rígido y repetitivo, como repetir las palabras o frases una y otra vez, exactamente de la misma forma (ecolalia).
Estímulos sensoriales	Algunos/as niños/as con TEA presentan alteraciones en el procesamiento de los estímulos sensoriales, que se puede manifestar en malestar intenso ante determinados sonidos, olores, sabores, texturas; interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (como insistencia por oler, chupar o tocar determinadas cosas); fascinación por objetos brillantes o que giran, o indiferencia aparente al dolor o a la temperatura.

Fuente: PRONAP 2022 - Módulo 1. Dra. A. Vericat, Abordaje de los problemas del neurodesarrollo.

3. Atención a las comorbilidades

Los pediatras debemos estar atentos a las comorbilidades y tener precaución sobre las manifestaciones atípicas de los síntomas de enfermedades comunes, a cambios repentinos en el comportamiento de personas con TEA. Muchas veces, se atribuyen a la condición, ciertas dificultades conductuales que, en realidad, responden a padecimientos clínicos no sospechados.

Las dificultades en la comunicación y las alteraciones sensoriales que afectan la percepción del dolor pueden confundir al profesional o a la familia.

Tabla 5. Comportamientos que podrían indicar dolor o enfermedad subyacente

Pérdida de pautas adquiridas.	Posturas.
Cambio súbito de comportamiento.	Comportamientos vinculados con la eliminación.
Irritabilidad, berrinches.	Auto o heteroagresiones.
Perturbaciones del sueño.	Puntas de pie.
Taparse los oídos.	Comer o beber en exceso.
Cambio en la alimentación.	Muecas o gestos.
Ansiedad o evitación.	Carraspeo.
Movimientos repetitivos.	Sollozo.
Hiperreactividad sensorial.	Agitación, parpadeo, gritos.

Problemas gastrointestinales⁴. Se describe que los niños con TEA tienen síntomas digestivos con mayor frecuencia que aquellos con desarrollo típico⁵. Diarrea, estreñimiento, distensión, dolor abdominal, eructos, flatulencias y reflujo gastroesofágico, podrían ser consecuencia de varios factores.

Por un lado, muchas personas con autismo tienen **selectividad alimentaria** pertinaz, por lo que el aporte de nutrientes y fibras suele estar desbalanceado. A su vez, la rigidez propia del TEA interfiere con la posibilidad de generar modificaciones en los hábitos alimentarios.

El **hábito de pica** también es más frecuente en personas con TEA.

Esta complejidad requiere un **enfoque interdisciplinario** que incluya al pediatra, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo, etc. Además, esta intervención debe realizarse en el marco del tratamiento integral de la condición.

La **dieta** es un factor ambiental que puede afectar la sintomatología del TEA. La dieta restrictiva más comúnmente utilizada en la población con TEA es aquella que excluye gluten y/o caseína. Aunque informes anecdóticos sugieren una mejora en los síntomas gastrointestinales y/o conductuales en individuos con dichas dietas, estos hallazgos no se han confirmado en ensayos doble ciego controlados con placebo. Tampoco se ha demostrado que los niños con TEA sufran una mayor incidencia de enfermedad celíaca, alergia al trigo o alergia a la leche. Por lo tanto, actualmente no se recomienda que los niños con TEA sigan estas dietas indiscriminadamente. Sin embargo, es posible que algunos pacientes respondan positivamente a las dietas de exclusión, pero se desconoce cómo identificar a estos niños ni por qué podrían beneficiarse.

⁴ Madra M, Ringel R, Margolis KG. Gastrointestinal Issues and Autism Spectrum Disorder. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2020 Jul;29(3):501-513. doi: 10.1016/j.chc.2020.02.005. Epub 2020 Apr PMID: 32471598; PMCID: PMC8608248.

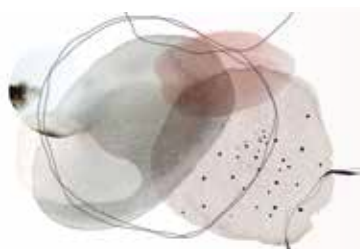
⁵ McElhanon BO, McCracken C, Karpen S, Sharp WG. Gastrointestinal symptoms in autism spectrum disorder: a meta-analysis. Pediatrics. 2014;133(5):872-883.

Estas dietas también presentan desventajas; pueden ser muy restrictivas y, por lo tanto, pueden agravar aún más los déficits nutricionales que estos pacientes podrían padecer. Si las familias están interesadas en probar una dieta excluyente, deben hacerlo en estrecha colaboración con el pediatra. Déficit nutricionales: las dietas restrictivas ponen en riesgo la adecuada nutrición. Por ello, el pediatra debe estar atento, no sólo a la desnutrición y al sobrepeso/obesidad, sino también a las posibles carencias de micronutrientes: hierro, calcio, vitaminas: A, C, D, complejo B, folatos, etc.

Un factor importante en el que la dieta puede influir en el comportamiento y/o la función gastrointestinal se basa en su capacidad para alterar el **microbioma intestinal**. Se ha demostrado que la composición de la flora intestinal tiene impacto en el comportamiento, el estado de ánimo, la cognición y problemas gastrointestinales, tanto en estudios preclínicos como clínicos. Hay estudios que prueban que algunos niños con TEA tienen poblaciones de microbiota intestinal diferentes a las de los niños neurotípicos. Sin embargo, las muestras han sido pequeñas y los resultados extremadamente variables.

Estos planteos requieren aún muchas investigaciones para poder utilizarlos en la práctica clínica con fundamento científico.

También se describe la comorbilidad con otros **trastornos del desarrollo** como TDAH, Discapacidad Intelectual, Trastorno del lenguaje, trastornos específicos del aprendizaje. Asimismo, el TEA puede coexistir con trastornos psiquiátricos o ser una expresión funcional de enfermedades genéticas.



De las comorbilidades médicas asociadas con el TEA, las convulsiones, los trastornos del sueño y los problemas psiquiátricos tienden a ser las afecciones más comúnmente asociadas con la disfunción gastrointestinal.

4. Evaluación integral

Ante la detección de señales de alerta o una pesquisa positiva de TEA, por el pediatra es preciso derivar al paciente para realizar una evaluación integral especializada. El pediatra puede interconsultar con un pediatra del desarrollo, neurólogo infantil o psiquiatra infantojuvenil (depende de los recursos que disponga en su ámbito laboral).

Para realizar dicha derivación el pediatra debería:

- **Confeccionar una historia clínica** orientada al desarrollo, que haga hincapié en:
 - Antecedentes perinatales, personales patológicos y familiares.
 - Resultados de pesquisas del nacimiento.
 - Las características de la adquisición de hitos del desarrollo: edades de adquisición por áreas, aspectos cualitativos y ponderar si hubo regresiones.
 - Examen físico completo y minucioso que observe: dismorfias, antropometría incluyendo

el perímetro cefálico a cualquier edad, examen de la piel en busca de estigmas neurocutáneos, visceromegalias, examen neurológico etc.

- Descripción del desempeño del niño en todas las áreas del desarrollo.
- Informes del desempeño y comportamiento en jardín o escuela.
- **Administrar una herramienta de pesquisa de TEA:** Instrumentos como el M-CHAT o el CSBL- DP son herramientas sencillas que el pediatra dispone para la detección temprana de TEA. Se trata de cuestionarios dirigidos a los cuidadores con preguntas orientadas a identificar señales de alerta. Una pesquisa positiva facilita la derivación a profesionales especializados. Están disponibles en forma gratuita en internet y allí se explica su uso (<https://www.panaacea.org/?p=test>).

a. Evaluación diagnóstica de TEA

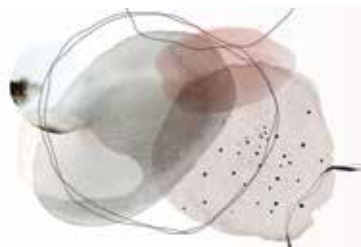
Para comprender la complejidad de los TEA y diseñar el tratamiento como “un traje a medida” de las características y posibilidades de los pacientes, el diagnóstico se establece en base a tres ejes:

- Diagnóstico categórico.
- Diagnóstico etiológico.
- Diagnóstico funcional.

Asimismo, **es preciso establecer diagnósticos diferenciales y de comorbilidades.**

- El **diagnóstico categórico** es el más reconocido en la práctica médica. Se basa en los manuales de clasificación diagnóstica de la Asociación de Psiquiatría Estadounidense Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en castellano -Manual diagnóstico de enfermedades mentales (DSM 5) y de la OMS - Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10-11). Los diagnósticos codificados en estos manuales se realizan agrupando distintos signos y síntomas que determinan una entidad nosológica.
- **El diagnóstico etiológico** permite conocer las causas, o alguna de ellas. Se sabe que no hay un marcador biológico para diagnosticar TEA y que la **etiología es multifactorial**. Existe una base hereditaria en el autismo, aunque no siempre pueden identificarse los genes afectados. Algunos casos de TEA se asocian a una causa reconocida, lo que se conoce como autismo sindrómico. Por ejemplo, el Síndrome de X frágil, Esclerosis Tuberosa, entre otros.
- **El diagnóstico funcional** es el propuesto por la OMS a través de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF). El funcionamiento es lo que una persona puede hacer en su vida cotidiana, incluida la participación social. Es más informativo que el diagnóstico en sí mismo para comprender el perfil individual de la persona con TEA. La CIF permite delinear el perfil de fortalezas y desafíos del individuo y describir las características del contexto que los rodea, que puede funcionar como una barrera o un facilitador para realizar sus actividades y participar en la sociedad. En **Argentina existe la herramienta TEA-CIFunciona**, que permite la evaluación funcional de las personas con TEA⁶.

⁶ Napoli SB, Vitale MP, Urinovsky MG, Fassero MP, et al. Evaluación funcional de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de trastorno del espectro autista en Argentina: estudio multicéntrico TEA-CIFunciona. *Arch Argent Pediatr*. 2024; 122(5):e202310171.



De los tres, el diagnóstico funcional es el más útil para diseñar el tratamiento. Aquí el pediatra tiene un rol muy importante, ya que conoce al paciente, la familia, su contexto y los recursos del ámbito donde desempeña su labor.

b. Determinación de la severidad del TEA

La clasificación del DSM-5 incluye dentro de la descripción del diagnóstico, el nivel de severidad del TEA. Esto se relaciona con la necesidad de apoyos de la persona y corresponde al diagnóstico funcional. El coeficiente intelectual, el desarrollo del lenguaje y la severidad de la conducta tienen un impacto directo en esta definición.

Nivel 1: “requiere apoyo” Graves deficiencias en el funcionamiento.

Nivel 2: “requiere apoyo sustancial”.

Nivel 3: “requiere apoyo muy sustancial”.

Nivel	Comunicación social	Conductas restringidas y repetitivas
1	Sin apoyos, se observan deficiencias notables. Dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuesta atípica o infructuosa a las propuestas sociales de los demás. Puede parecer que ha disminuido el interés por las interacciones sociales.	La inflexibilidad de la conducta causa una interferencia significativa en el funcionamiento en uno o más contextos . Dificultad para cambiar de actividad. Los problemas de organización y planificación dificultan la independencia.
2	Deficiencias marcadas en las habilidades de comunicación social verbal y no verbal. Deficiencias sociales evidentes incluso con apoyos; inicio limitado de interacciones sociales; y respuestas reducidas o anormales a las propuestas sociales de los demás.	La inflexibilidad de la conducta, la dificultad para afrontar los cambios u otras conductas restringidas o repetitivas aparecen con la frecuencia suficiente como para resultar obvias para el observador casual e interfieren en el funcionamiento en diversos contextos. Angustia o dificultad para concentrarse en otra cosa o cambiar de acción.
3	Inicio muy limitado de las interacciones sociales. Una respuesta mínima a las propuestas sociales de los demás.	La inflexibilidad de la conducta, la dificultad extrema para afrontar los cambios u otras conductas restringidas/repetitivas interfieren notablemente con el funcionamiento en todas las áreas . Gran angustia o dificultad para concentrarse en otra cosa o cambiar de acción.

c. Evaluación por especialistas

Las evaluaciones que el especialista realizará serán las siguientes:

- **Evaluación clínica basada en criterios del DSM V.**

La misma puede apoyarse con evaluaciones estandarizadas: Las más utilizadas son el ADOS y ADI-R. Hay muchas otras pruebas disponibles en nuestro medio: Pruebas de teoría de la mente, la Escala australiana de Asperger, escala CARS, AMSE, etc.

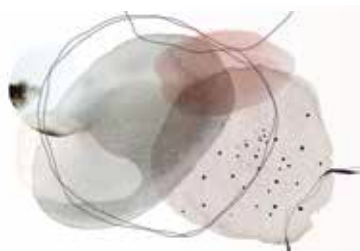
El **ADOS-2** es una escala de diagnóstico, estandarizada y semiestructurada que utiliza el juego y la conversación para obtener información acerca de las características de la comunicación social y la conducta repetitiva, restringida del niño o adulto con sospecha de tener un trastorno del espectro autista. Debe ser administrada por un profesional capacitado y habilitado. El ADOS 2 está diseñado para la evaluación de personas desde los 12 meses de edad hasta la edad adulta.

El **ADI-R** es una entrevista clínica que se realiza a los cuidadores y permite una evaluación profunda de sujetos con sospechas de autismo. Se aplica desde los 2 años hasta la edad adulta.

La escala **CARS** es una herramienta de evaluación diseñada para medir la presencia y la gravedad de los síntomas del autismo en niños. Se basa en la observación clínica del niño en diferentes áreas de funcionamiento, incluyendo la comunicación, la interacción social, el comportamiento estereotipado y la respuesta emocional.

AMSE (Autism Mental Status Exam, o en castellano Examen del Estado Mental en Autismo) es una evaluación observacional de 8 ítems que estructura la forma en que los Médicos y Profesionales de la Salud observan y documentan el funcionamiento social, comunicativo y conductual en personas con TEA.

AMSE está diseñado para llevarse a cabo en el contexto de una entrevista clínica y no agrega trabajo adicional al entrevistador. Podría ser utilizado en la consulta pediátrica. Su trabajo de validación en Argentina está próximo a publicarse.



Es importante aclarar que estas evaluaciones son complementarias y se emplean como apoyo al diagnóstico clínico de TEA (categórico), pero no lo reemplazan. Las dificultades para acceder a las mismas suelen obstaculizar el acceso al tratamiento y la intervención temprana.

- **Escalas para medir el coeficiente intelectual (WISC V, WPPSI, entre otras).**

Evaluación del desempeño cognitivo: Se realiza a través de pruebas estandarizadas, que producen puntuaciones que se comparan con poblaciones normativas.

WISC-V y WPPSI IV son las evaluaciones más conocidas y miden la capacidad del sujeto para resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones, pensar de manera abstracta y comprender ideas complejas. Evalúan habilidades específicas como razonamiento, memoria, comprensión verbal y habilidades de procesamiento.

El objetivo principal es cuantificar la capacidad cognitiva, identificando fortalezas y debilidades relacionadas con el rendimiento académico y el potencial intelectual.

- **WISC-V** (Wechsler Intelligence Scale for Children, Quinta Edición) evalúa la inteligencia en niños y adolescentes de 6 a 16 años.
- **WPPSI, IV** es una extensión descendente del WISC. Permite la evaluación del funcionamiento cognitivo de los niños entre 4 y 6 años.

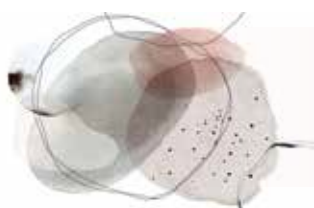
Interpretación de los resultados: Una puntuación media de 100 (percentil 50) $\pm$ 15 indica un funcionamiento en la media. Una puntuación inferior a 85 (1 DE por debajo de la media), en el percentil 16, indica un deterioro leve y una puntuación inferior a 70 (2 DE por debajo de la media) señalan una discapacidad intelectual.

- **Escalas para medir índice de desarrollo**

Consideran el progreso en múltiples áreas, como el desarrollo motor, el lenguaje, las habilidades sociales y emocionales, así como el desarrollo cognitivo. Se aplican en niños menores de 4 años o mayores, pero con funcionamiento cognitivo menor de esa edad: **Escalas de Bayley y Mullen.**

La **Escala Bayley** de Desarrollo de Bebés y Niños Pequeños (Tercera Edición) es una serie estándar de mediciones utilizadas principalmente para evaluar el desarrollo motor (fino y grueso), del lenguaje (receptivo y expresivo) y cognitivo de bebés y niños pequeños de 0 a 42 meses. Permite evaluar al paciente a través del tiempo y confeccionar una curva de desarrollo.

La **Escala Mullen** es similar al Bayley, pero más breve. Evalúa cinco áreas del desarrollo infantil: motricidad gruesa, recepción visual, motricidad fina, lenguaje expresivo y lenguaje receptivo.



La interpretación de los resultados es similar a la empleada en las pruebas de inteligencia WISC y WPPSI.

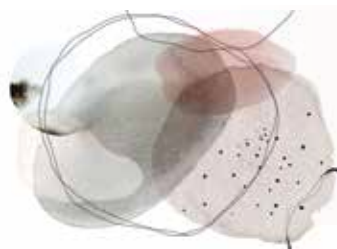
- **Escalas de inteligencia no verbal**
 - **Leiter 3** es una prueba completamente no verbal que es ideal para usar con personas con retraso cognitivo, del lenguaje oral, trastornos del espectro autista y quienes hablan otro idioma.
- **Escalas para medir el desempeño adaptativo. (Escala adaptativa de Vineland)**

La conducta adaptativa es un concepto diferente de la inteligencia. Las conductas adaptativas son habilidades aprendidas que reflejan la competencia social y práctica de un individuo para afrontar las exigencias de la vida cotidiana:

- Habilidades conceptuales: alfabetización, autodirección y conceptos de número, dinero y tiempo.
- Habilidades sociales: habilidades interpersonales, responsabilidad social, autoestima, credulidad, ingenuidad (es decir, cautela), resolución de problemas sociales, seguir reglas, obedecer leyes y evitar ser víctima.
- Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria (cuidado personal), habilidades ocupacionales, uso del dinero, seguridad, atención médica, viajes/transporte, horarios/rutinas y uso del teléfono.

Las **Escalas de Conducta Adaptativa de Vineland** son las pruebas más utilizadas en nuestro medio para medir la conducta adaptativa de personas de 0 a 90 años con diagnóstico de: discapacidades intelectuales y del desarrollo, trastornos del espectro autista (TEA), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), etc.

La interpretación de los resultados es similar a la empleada en las pruebas de inteligencia WISC y WPPSI.



El perfil cognitivo tiende a mantenerse estable a lo largo del tiempo. Mientras que la conducta adaptativa puede modificarse a partir del aprendizaje.

- Evaluación **fonoaudiológica neurolingüística**: para determinar el nivel de lenguaje y las habilidades comunicativas.
- Evaluación de **terapia ocupacional** que incluya el perfil sensorial.
- Evaluación de **comorbilidades**: otros trastornos del desarrollo y problemas psiquiátricos.

5. Trabajo coordinado

Es fundamental, como pediatra de cabecera, acompañar a la familia, brindar información, hacerla parte del proceso diagnóstico y terapéutico.

La **derivación a especialistas** es un aspecto delicado, que exige al pediatra adaptarse al contexto: los recursos disponibles y las posibilidades de acceso de la familia. El autismo es una condición del desarrollo que afectará al paciente durante su curso de vida. Por tanto, el rol del pediatra es clave para acompañar a la familia como coordinador de la intervención. Para ello, se requiere trabajar en red para gestionar los apoyos que el niño requiera, optimizando los recursos existentes en su entorno. En función de esto deberían considerarse las siguientes premisas:

- El pediatra debe conocer los recursos médicos, sociales, educativos, recreativos disponibles en su contexto laboral. Deberían optimizarse los mismos para facilitar el acceso y la vida cotidiana de las familias. Limitar las derivaciones a sitios lejanos para cuando la situación lo amerite, realizando una estimación de costo-beneficio.
- Puede ayudar a la familia a tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- Acompañarla en el proceso de escolarización y participación en actividades recreativas.
- Atender los problemas de salud que suelen afectar a las personas con TEA, problemas de alimentación, sueño, gastrointestinales, odontológicos, sensoriales (déficit visual y/o auditivos), ortopédicos, etc.
- Desaconsejar exposición prolongada a pantallas, etcétera.
- Potenciar las fortalezas e intereses de la persona con TEA.

6. Tratamiento y terapias

Dado que **el autismo es una condición del neurodesarrollo y no una enfermedad**, no tiene cura. La terapéutica está orientada a potenciar las capacidades del individuo y atenuar el impacto de sus desafíos. La heterogeneidad en la presentación clínica y el sustrato etiopatogénico complejo representan un desafío para el desarrollo de tratamientos efectivos y basados en la evidencia. Esto hace que se existan numerosas intervenciones, algunas con dudosa o nula rigurosidad científica.

Se brindarán en este apartado, **lineamientos generales**. Esta información puede ampliarse en el Consenso Argentino sobre Trastornos del Espectro Autista elaborado por el Ministerio de Salud de la nación argentina en 2019, mediante un panel de expertos.

- Prácticas basadas en la evidencia.
- Intervenciones tempranas: destinadas a niños de 0 a 6 años, diseñadas para promover la adquisición o mejora de habilidades socio-comunicativas, cognitivas, adaptativas, sensorio-motoras, de autorregulación y de juego de niños y niñas pequeños con TEA.
- Que dichas intervenciones involucren la participación activa de sus padres y/o entorno significativo primario (hermanos, cuidador principal, etc.).
- Que el plan de tratamiento sea establecido teniendo en cuenta las áreas del desarrollo afectadas y el nivel de severidad, de acuerdo con las prioridades de la familia.
- Seguimiento y reevaluación periódica, definiendo los objetivos terapéuticos propuestos, las prestaciones necesarias para cumplirlos y la frecuencia, duración e intensidad necesarias de las intervenciones.

En forma genérica, **los tratamientos están enfocados:**

- Los síntomas nucleares de la condición:
 - Abordajes basados en teorías alternativas de aprendizaje (como los basados en el análisis conductual aplicado o terapia cognitivo conductual).
 - Abordajes relacionales basados en hipótesis del desarrollo (como DIR- Floortime, Denver Model, RDI, Scerts, etc.).
 - Estrategias educativas (como TEACCH).

Estos marcos teóricos se aplican en terapias de fonoaudiología, terapia ocupacional con integración sensorial, psicología, psicopedagogía, musicoterapia, psicomotricidad.

B. Farmacológico para los síntomas asociados: irritabilidad, agresividad, trastornos del sueño.

C. Intervenciones nutricionales: aporte de micronutrientes carentes en la dieta.

E. Tratamiento de las comorbilidades.

La elección del tratamiento apropiado para el TEA es compleja y dinámica, por lo que debe basarse en la identificación de las capacidades y las necesidades específicas de cada paciente a partir de un proceso de diagnóstico interdisciplinario y de seguimiento a lo largo del curso vital. El mejor tratamiento sería de comienzo temprano, intensivo y diseñado como un “traje a medida” de las características del paciente y de su contexto físico, familiar y sociocultural a lo largo del tiempo.

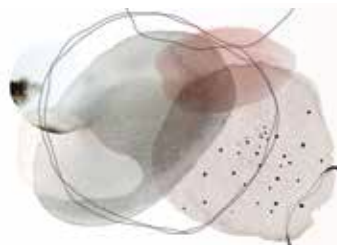
7- Atención de los pacientes

La visita de un paciente con TEA al pediatra puede ser una situación estresante para el niño y su familia. Los motivos pueden ser varios:

- Miedo a lo desconocido.
- Desafíos de comunicación y sensoriales.
- Experiencias previas de dolor o dolor agudo.

Estas situaciones pueden desencadenar estallidos emocionales, auto o heteroagresiones, que trae como consecuencia que los niños con TEA concurren menos frecuentemente a controles regulares en salud. Asimismo, suelen llegar a la guardia con cuadros avanzados, que podrían tener mayor gravedad.

Para mejorar la experiencia y facilitar la consulta y el vínculo médico-paciente-familia, conviene que el pediatra considere algunas precauciones con el fin de prevenir situaciones desencadenantes y lograr un encuentro agradable y fructífero.



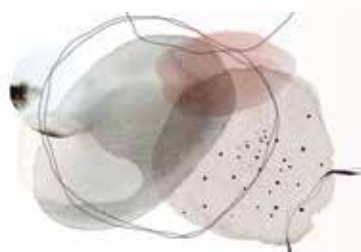
Las personas con TEA suelen ser estructuradas. Cuanto más predecible sea la situación, más probabilidades de éxito tendrá la consulta.

Para ello, algunas sugerencias:

- Fomentar la consulta frecuente, para que el niño se familiarice con el pediatra y con su consultorio, estando saludable. Esto facilitará las acciones en caso de urgencia, dolor o alguna molestia.
- Pedir a la familia que anticipe al niño la consulta: utilizar apoyos visuales, por ejemplo: mostrándole fotos del pediatra, del consultorio, de los objetos, jugando en casa al doctor, etc.
- Citar, preferentemente, en el primer turno disponible, en momentos donde la sala de espera esté menos llena y evitar que el tiempo de espera sea prolongado.

- Permitir a los niños explorar los materiales con los que serán revisados.
- Evitar, en lo posible, las luces, los ruidos fuertes.
- Hablarles en tono sereno y con pocas palabras.
- Facilitar la vía visual para anticipar las acciones. El pediatra podría disponer de pictogramas para facilitar la comprensión, o bien usar el sistema de comunicación que emplee el paciente.

8. Importancia de la inclusión



El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala la obligación del Estado Argentino de garantizar un sistema de educación que sea inclusivo en todos los niveles y que las personas con discapacidad no puedan quedar excluidas de las escuelas generales.

La **inclusión educativa** ofrece beneficios tanto para la persona con TEA como para la comunidad. Respecto de los niños con autismo, la escolaridad favorece el desarrollo de habilidades sociales y de actividades para la vida, permite mejorar su autoestima y les brinda acceso a oportunidades educativas. Recíprocamente, la sociedad se beneficia al promover la diversidad e inclusión y es una oportunidad para aumentar la conciencia y comprensión sobre el autismo.

Los pediatras debemos interiorizarnos acerca de las variables existentes y las disposiciones legales de cada jurisdicción para asesorar a las familias.

9. Apoyo familiar

Recibir el diagnóstico de TEA puede ser devastador para algunos padres, mientras que para otros puede ser un alivio al entender mejor los comportamientos de su hijo. Muchos padres se sienten abrumados por la angustia y el miedo al imaginar cómo cambiarán sus expectativas para el futuro de sus hijos. En estos casos, participar en grupos de apoyo y conectar con otros padres puede ser muy útil. Sin embargo, estos sentimientos intensos también pueden impulsar a los padres a buscar ayuda y tratamientos durante la crucial fase de intervención temprana. Un diagnóstico es vital porque abre la puerta a numerosos servicios y recursos que pueden informar a los padres sobre tratamientos que han sido efectivos para otros niños.

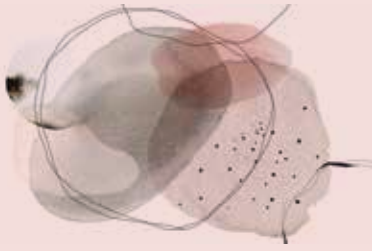
Es fundamental destacar que las personas con TEA tienen la capacidad de aprender y desarrollarse con progresiva autonomía. A pesar de lo que puedan escuchar de profesionales desinformados o leer en textos obsoletos, el autismo es tratable.

Es esencial acceder a servicios, tratamientos y educación efectivos lo antes posible. Cuanto más pronto reciban el apoyo adecuado, mejores serán sus perspectivas, aunque nunca es demasiado tarde para mejorar su calidad de vida. Puede que su progreso sea más lento que el de sus pares, pero con el respaldo adecuado, pueden llevar vidas felices y productivas.

LINKS

Páginas de grupos de padres con niños con TEA:

- Fundación Brincar por un autismo feliz: <https://www.brincar.org.ar>
- APADEA: Asociación de padres de autistas: <https://apadea.org.ar>
- TGD padres TEA: <https://tgd-padres.com.ar/index.html>
- Autism Speaks: <https://www.autismspeaks.org>



Autoevaluación

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

	V	F
1. El autismo es una condición del neurodesarrollo, no una enfermedad. No tiene cura, pero puede tratarse para mejorar la calidad de vida.	☐	☐
2. Un niño con TEA que presenta lenguaje fluido no requiere evaluación funcional adicional.	☐	☐
3. Las alteraciones sensoriales en el TEA pueden manifestarse como hiperactividad o hiporreactividad a estímulos.	☐	☐
4. El M-CHAT-R/F es una herramienta útil para la pesquisa de TEA en niños entre 16 y 30 meses.	☐	☐
5. Los niños con TEA suelen tener una alimentación variada y equilibrada.	☐	☐
6. La presencia de estereotipias motoras en niños con TEA siempre indica un bajo nivel de funcionamiento cognitivo.	☐	☐
7. El diagnóstico de TEA en niñas requiere considerar factores como el camuflaje social y las estrategias compensatorias.	☐	☐
8. El uso de pictogramas puede facilitar la consulta médica en niños con TEA.	☐	☐
9. El examen físico en niños con sospecha de TEA debe incluir la evaluación de dismorfias y estigmas neurocutáneos.	☐	☐
10. La derivación a especialistas debe realizarse cuando el pediatra ha descartado todas las causas médicas.	☐	☐

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

TOMÁS, 4 AÑOS

La familia consulta al pediatra porque la alimentación de Tomás es sumamente selectiva.

Antecedente Recién nacido prematuro, de 33 semanas por preeclampsia. Peso de nacimiento 1.700 g. Tuvo dificultades tempranas en la succión. Se alimentó por sonda orogástrica durante 3 semanas. Permaneció en neonatología sólo para control nutricional. No recibió lactancia materna. Incorporó semisólidos y sólidos sin dificultad. A partir de los 18 meses empezó a presentar un comportamiento alimentario sumamente selectivo. Actualmente sólo acepta alimentos blancos y carnes, no come frutas ni verduras, excepto papas fritas.

Al **examen físico** presenta peso en percentil 90. Talla y circunferencia cefálica en percentil 50, sin signos de anemia.

El pediatra realiza una historia clínica orientada al desarrollo en la que parte de las preocupaciones de los padres. Si bien sólo consultaron por la alimentación, también comentan que tiene berrinches intensos, que no se incluye en las actividades grupales en el jardín, que no asiste a cumpleaños porque llora desconsoladamente al momento de la torta.

Tomás no tiene otros antecedentes clínicos relevantes, ni familiares de trastornos del desarrollo, neurológicos ni psiquiátricos.

Adquirió el sostén cefálico a los 2 meses de edad corregida, sedestación a los 7 y la marcha autónoma a los 15 de edad cronológica.

Fue un bebé tranquilo, poco demandante de atención. Siempre durmió mucho. Dijo sus primeras palabras a los 18 meses y frases a los 2,5 años. Logró el control de esfínteres diurno a los 3 años. No tuvo pérdida de pautas del desarrollo.

En la interacción con el niño el pediatra observa que Tomás establece contacto visual de manera fugaz, tiene uso limitado del lenguaje, emplea frases cortas con entonación peculiar. Posee intereses intensos en los trenes y cuesta convocarlo para hacer actividades. Repite frecuentemente frases de una película de trenes.

El pediatra intenta administrar la PRUNAPE, pero el niño no se acondiciona a la prueba y no sigue las consignas.

¿Cuál es su próxima acción?

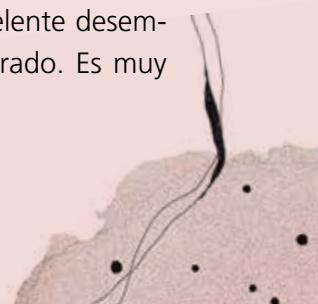
- a) Realizar una evaluación profunda de las características de la alimentación y solicitar exámenes complementarios para detectar déficits de micronutrientes y vitaminas.
- b) Consultar con un especialista en desarrollo para realizar una evaluación integral.
- c) Solicitar un informe escolar.
- d) Todas son correctas.

ANA, 6 AÑOS

Los padres de Ana consultan al pediatra porque la niña presenta dificultad en la regulación emocional (explosiones de ira), resistencia a cambios en la rutina, interacción social limitada; prefiere jugar sola y sensibilidad extrema a estímulos sensoriales (ruidos fuertes).

Antecedentes Ana nació de término, con peso adecuado, vigorosa. No tuvo complicaciones en la etapa neonatal. Las pesquisas de nacimiento (OEA y PPN fueron normales). Adquirió a tiempo las pautas de desarrollo motor y del lenguaje. Fue largo el proceso de control de esfínteres: siempre retuvo materia fecal, hasta la actualidad. Aprendió a leer a los 3 años. No tuvo enfermedades importantes. Siempre tuvo un sueño muy liviano y frecuentes despertares. Su alimentación es bastante limitada en variedad, pero recibe alimentos de todos los grupos.

Ana es única hija de padres sanos, informáticos. Refieren que ambos tuvieron excelente desempeño académico y que siempre fueron poco sociables. Está escolarizada en 1er grado. Es muy aplicada, ya está alfabetizada y no tiene dificultades en el aprendizaje.



Al **examen físico** se muestra colaboradora, inquieta. Responde a preguntas de manera escueta y no inicia intercambios comunicativos con el pediatra. Tiene peso, talla y perímetro cefálico en percentil 25. Abdomen ligeramente distendido, no doloroso, con ruidos hidroaéreos presentes, se palpa cuerda cólica. Sin otros datos positivos.

Se solicita informe escolar donde surge que la niña tiene buen desempeño académico. En los recreos se aparta del grupo y prefiere leer siempre en el mismo rincón. Tiene explosiones de ira si algún compañero ocupa su banco en el aula.

El pediatra deriva a evaluación del desarrollo y la niña recibe el diagnóstico de trastorno del espectro autista con desempeño cognitivo en rango promedio y buen desarrollo del lenguaje. Además, presenta dificultades para conciliar el sueño, siendo este muy liviano y tiene frecuentes despertares.

¿Cuáles de las siguientes acciones podría implementar el pediatra como primer paso?

- a) Medicar con melatonina.
- b) Investigar acerca de la higiene del sueño, observar datos clínicos que pudieran indicar apneas obstructivas y trataría el estreñimiento.
- c) Solicitar un electroencefalograma y, con el resultado, consultar con neurología.
- d) Derivar a psiquiatría para que considere un tratamiento psicofarmacológico.

JUAN, 14 AÑOS

Juan es un adolescente de 14 años, lo consultan por primera vez porque presenta dificultades para entender las normas sociales y las interacciones: le cuesta mantener amistades, tiene intereses restringidos: programación y comportamientos repetitivos: tics y movimientos estereotipados de las manos. Está en segundo año de secundaria. Le genera mucha ansiedad la escuela, se resiste a ingresar y tiene quejas somáticas frecuentemente. Padece de estreñimiento crónico con pobre adherencia al tratamiento con laxantes y dieta. No le gusta ningún deporte.

De la **anamnesis** surge que fue producto de un embarazo controlado y normal. Nació a término, vigoroso, con peso adecuado. Sin complicaciones neonatales. Pesquisas normales. Adquisición a tiempo de pautas de desarrollo motor y cognitivo sin regresiones. En el jardín de infantes deambulaba y "era muy físico". Tiene sólo dos amigos que fueron compañeros desde el jardín y la escuela primaria. Las dificultades sociales se hicieron más evidentes cuando empezó la escolaridad secundaria, donde cambió de colegio.

De los **antecedentes** surge que tiene un hermano menor, de 7 años, con reciente diagnóstico de TDAH.

¿Qué acciones debería priorizar el pediatra?

- a) Solicitar evaluación por especialista del desarrollo por posible TEA y comorbilidades. Incluir en evaluación perfil neurocognitivo, académico y síntomas psíquicos (ansiedad, trastorno del estado de ánimo).
- b) Recomendar a la familia realizar un cambio de escuela para reiniciar su adaptación e indicar enemas diarios y un cambio en la alimentación para ayudar a mejorar su constipación.
- c) Indicarle la práctica de fútbol para favorecer la socialización y dieta rica en fibras.
- d) Todas son correctas.

CONCLUSIONES

La atención pediátrica de pacientes con TEA representa una serie de desafíos multifacéticos que requieren una comprensión profunda y un enfoque integral. Uno de los principales desafíos es la identificación y diagnóstico tempranos, ya que los síntomas pueden variar significativamente en su presentación. Esta variabilidad puede llevar a diagnósticos tardíos, lo cual retrasa el acceso a intervenciones cruciales.

Además, los médicos debemos ser capaces de adaptarnos a las diferencias en la comunicación y el comportamiento de los niños con TEA. Los profesionales de salud a menudo nos enfrentamos a dificultades para establecer una relación de confianza, dado que muchos pacientes pueden presentar dificultad de comprensión, ansiedad, sensibilidad sensorial y comportamientos desafiantes. Este escenario exige que los pediatras y otros profesionales de la salud seamos flexibles y estemos capacitados en técnicas de comunicación y enfoques terapéuticos adaptados.

Otro reto importante es la coordinación del cuidado. Estos niños frecuentemente requieren la colaboración de un equipo multidisciplinario que incluye al pediatra de cabecera, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, psicólogos, docentes, entre otros. La falta de comunicación y coordinación entre las partes puede resultar en un tratamiento fragmentado, lo que afecta la efectividad de las intervenciones.

Además, las familias de estos pacientes enfrentan su propio conjunto de desafíos. La carga emocional y financiera que conlleva el cuidado de un niño con TEA puede ser abrumadora.

Los pediatras podemos ofrecer apoyo a las familias, brindando recursos y orientación para ayudarlos a navegar por el sistema de atención médica.

Para abordar estos desafíos, es esencial fomentar una formación continua para los profesionales de la salud y la educación en el campo del TEA y promover una mayor conciencia y comprensión en la comunidad. La empatía, la paciencia y un enfoque centrado en la familia son componentes clave que pueden mejorar la calidad de atención y, en última instancia, la calidad de vida de los pacientes con TEA y sus familias.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo. Libro violeta de desarrollo infantil. Guía para el seguimiento en el primer nivel de atención. E. Abeya Gilardon et al; Ediciones SAP. 2023.
- Libro Violeta 2. Atención Integral de los problemas del desarrollo infantil. E. Abeya Gilardon et al; Comité Nacional de Crecimiento y Desarrollo. SAP 2025.
- Consenso sobre diagnóstico y tratamiento de personas con TEA. Secretaria de Gobierno de Salud, Ministerio de Salud y Desarrollo Social, Presidencia de la Nación, 2019.
- Comité de Crecimiento y Desarrollo. Guía para el seguimiento del desarrollo infantil en la práctica pediátrica. Arch Argent Pediatr. 2017;115 (Supl 3):s53-s62. doi: 10.5546/aap.201.s53

CLAVE DE RESPUESTAS

I. Lea los siguientes enunciados e identifique si son verdaderos (V) o falsos (F).

1. Verdadero.
2. **Falso.** El lenguaje estructurado no garantiza habilidades comunicativas funcionales ni sociales.
3. Verdadero.
4. Verdadero.
5. **Falso.** Muchos presentan selectividad alimentaria, lo que puede generar déficits nutricionales.
6. **Falso.** Las estereotipias pueden aparecer en distintos niveles cognitivos y no son exclusivas de bajo funcionamiento.
7. Verdadero.
8. Verdadero.
9. Verdadero.
10. **Falso.** La derivación temprana permite una evaluación multidisciplinaria más eficaz, incluso si no se han descartado todas las causas.

II. Analice y resuelva las siguientes situaciones clínicas.

1. SEBASTIÁN 18 MESES.

¿Cuál sería el paso siguiente luego de realizar una historia clínica orientada al desarrollo?

Respuesta correcta a) Aplicar una evaluación estandarizada de pesquisa: por ejemplo, M-CHAT/RF y solicita potenciales evocados auditivos.

2. TOMÁS 4 AÑOS.

¿Cuál sería su próxima acción?

Respuesta correcta d) Todas son correctas.

3. ANA, 6 AÑOS.

¿Cuáles de las siguientes acciones podría implementar el pediatra como primer paso?

Respuesta correcta b) Investigar acerca de la higiene del sueño, observar datos clínicos que pudieran indicar apneas obstructivas y trataría el estreñimiento.

4. JUAN, 14 AÑOS.

¿Qué acciones debería priorizar el pediatra?

Respuesta correcta a) Solicitar evaluación por especialista del desarrollo por posible TEA y comorbilidades. Incluir en evaluación perfil neurocognitivo, académico y síntomas psíquicos (ansiedad, trastorno del estado de ánimo).

